

항암치료 대상자의 치료 및 퇴원 후 자가 관리 교육 활동

팀명 : 암쏘암쿨

(암 so hot, 넌 너무 위험해! I'm so cool, 난 너를 물리쳤어)



1. 치료 과정, 예상 가능한 부작용 및 대처법에 대한 정보 제공이 불충분하다.
2. 의료진과의 상담시간 제약으로 인해 충분한 지식을 습득할 기회가 제한된다.
3. 퇴원 후 생활 습관 관리에 대한 명확한 가이드가 부족 하고, 환자들의 자가 관리에 대한 부담감이 증가하고 있다.
4. 고령의 환자 및 처음 항암을 진행하는 환자의 증가로 인해 관련 지식이 (항암 화학요법 진행과정 및 자가 간호 수행 능력) 부족한 환자가 증가했다.

현 수준

1. 환자 교육이 암환자의 지식과 자가간호 수행에 미치는 효과에 대한 참고 연구 자료

1) 제1가설 검증 결과

"환자 교육을 받지 않았을 때보다, 받았을 때 지식 정도가 높을 것이다"를 검증하기 위해 실험군의 교육 제공 후 자가간호 지식의 차이를 구한 후 전후의 평균 값을 비교하기 위해 Paired t-test 검정 결과는 표 2와 같다. 자가간호 지식 점수는 정보적 지지 제공 전 16.54에서 시행 후 17.54으로 나타나 교육 전후의 자가간호 점수는 통계적으로 유의한 차이를 나타내($t=-2.373$, $P=.026$). "환자 교육을 받지 않았을 때보다 받았을 때 지식 정도가 높을 것이다"라는 가설은 지지되었다.

〈표 2〉 교육 전후의 자가간호 지식정도 차이

n = 24				
	평 균	표준편차	t	P
교육 전	16.54	2.15	-2.373	.026
교육 후	17.54	1.72		

2) 제2가설 검증 결과

"환자 교육을 받지 않았을 때보다, 받았을 때 자가 간 호 수행 정도가 높을 것이다"를 검증하기 위해 실험군에 교육을 제공 후 자가간호 수행 점수의 차이를 paired t-test 결과는 〈표 3〉과 같다.

자가간호 수행 점수는 교육 제공 전 0.58에서 교육 후 1.18로 증가하였다. 교육 제공 전후의 자가간호 수행 점수는 통계적으로 유의한 차이를 나타내었다($t=-8.73$, $P=.000$). 따라서 "환자 교육을 받지 않았을 때보다, 받았을 때 자가간호 수행 정도가 높을 것이다"라는 가설은 지지되었다.

〈표 3〉 교육 전후의 자가간호 수행 정도 차이

n = 24				
	평 균	표준편차	t	P
교육 전	.5871	.3675	-8.73	.000
교육 후	1.1780	.4302		

출처: 조영수, 류은정, 최경숙. (2002). 화학요법에 관한 개별적 환자교육이 암환자의 지식과 자가간호 수행에 미치는 효과. Asian Oncology Nursing, 2(1), 27-35.

1. 환자 교육이 암환자의 지식과 자가간호 수행에 미치는 효과에 대한 연구 자료

결론적으로 환자개별교육이 항암화학요법 환자의 지식과 자가간호 수행정도에는 영향을 주는 것으로 나타나 자가간호 수행 정도를 증진시킬 수 있는 중요한 간호중재임을 확인하였다. 따라서 항암화학요법 환자에게 적절한 관리를 할수 있는 자가간호 수행을 위한 간호중재로 환자교육 프로그램의 적극적인 활용이 요구된다.

그러므로 이와 같은 결과를 바탕으로, 암환자 교육은 환자들이 그들의 질병을 이해하고 어떻게 자기 관리를 해야 할지를 알 수 있는 적절한 교육 전략이 된다. 따라서 암환자 교육은 자가간호 수행에 효과가 있음이 확인 되었으므로 보다 체계적이고 계획적인 그리고 지속적인 교육을 대상자들에게 제공한다면 대상자들이 그들의 질병 과정에 더 잘 적응하고 대처해 나갈 수 있을 것으로 사료된다. 그러므로 간호사는 환자 교육을 통하여 자가

없으므로 자기효능을 증진시키는 프로그램을 개발하고 활용함으로 자가간호수행과 관련된 간호의 독자적인 업무의 범주를 넓히고 보다 체계적인 교육을 할 수 있는 중재 방법을 강구해야 한다.

체계적이고 지속적인 교육
➡ **자가간호 ↑ 지식 ↑**

출처: 조영수, 류은정, 최경숙. (2002). 화학요법에 관한 개별적 환자교육이 암환자의 지식과 자가간호 수행에 미치는 효과. Asian Oncology Nursing, 2(1), 27-35.

2. 타 병원의 항암치료 대상자의 항암 및 퇴원 교육 사례

유방암이란 무엇인가요?



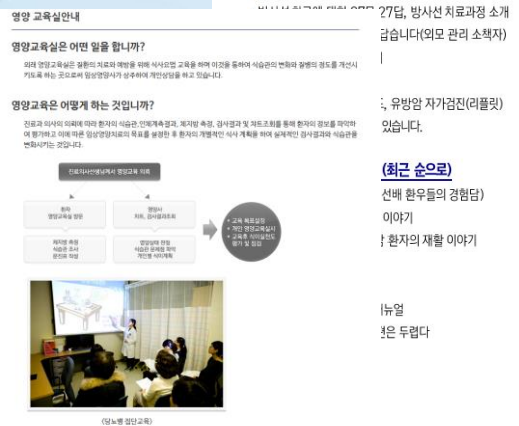
수많은 정보 속에서 과학적으로 믿음직한 자료를 찾는 것은 어렵고 또 어떤 것이 믿음직한 자료인지 판단하기는 더욱 힘듭니다. 하지만 잘못된 정보로 인해 제대로 된 치료를 받지 못함으로써 치료의 기회를 놓치기도 합니다. 따라서 저희 삼성서울병원 암교육센터에서는 유방암 환자와 가족을 위해 올바른 정보를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 제대로 된 정보로 자신의 암이 무엇인지 공부하여 암을 잘 극복하시기를 바랍니다. 여러분의 건강한 삶을 위해 최선을 다해 응원하겠습니다.

무료로 제공되는 유방암에 대한 자료

- 유방암(소책자)
- 암을 처음 진단 받았을 때 알아야 할 7가지
- 암환자 자기관리 수첩
- 유방 재건술 환자를 위한 가이드
- 유방암 수술 후 림프 부종
- 항암치료에 대한 이해



<유방암> 소책자



함께하는 진료 함께하는 행복

SMC 삼성서울병원

중(Zoom) 실시간 교육

유방암 치료 후 가이드 (생활관리, 신체활동)

유방암 치료가 끝난 후 건강 관리법과 도움이 되는 신체 활동에 대해 알려드립니다.

대상 수술, 항암 치료, 방사선 치료 등의 적극적인 유방암 치료가 끝나고 정기적인 검진을 받고 있는 환자

일정 유방암 치료 후 신체활동 - 매월 셋째 주 수요일 오후 3-4시
유방암 치료 후 생활관리 - 매월 셋째 주 수요일 오후 4-5시

참여 방법 ① 암교육센터로 전화 예약 ☎ 02-3410-6619
② 교육 당일에 문자로 참여 링크 받기
③ 교육 시간에 맞춰 참여 링크를 클릭하여 교육 듣기

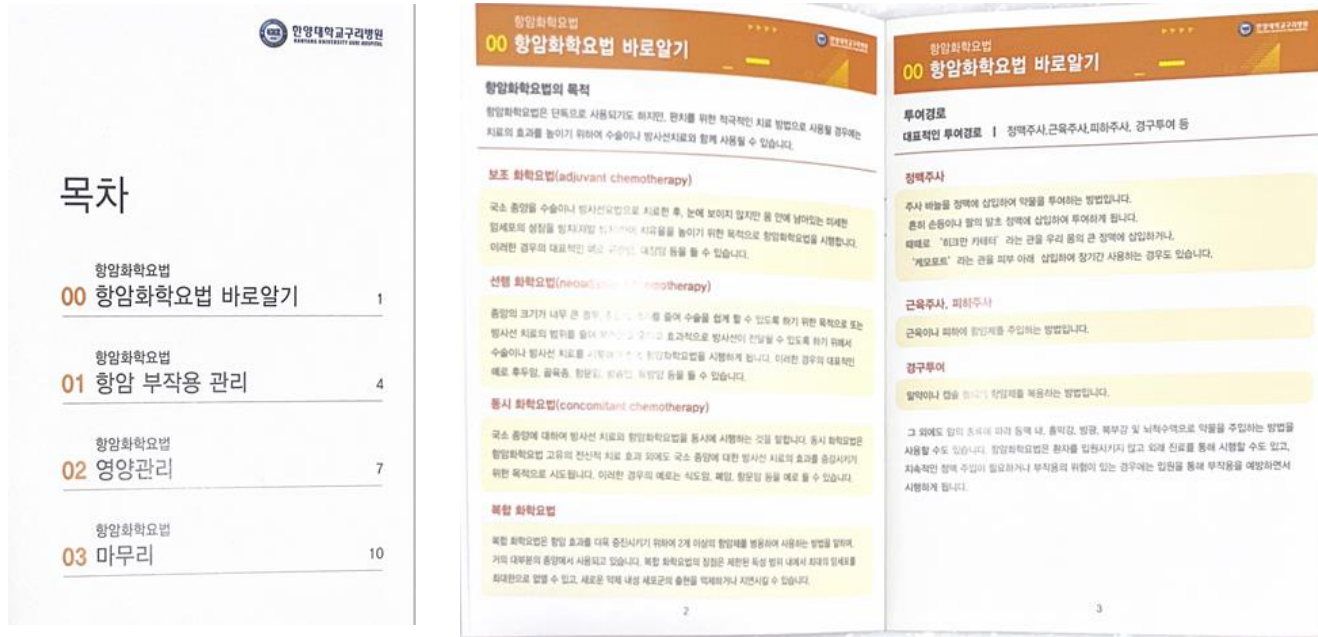
중으로 교육 참여를 위해서는 중(Zoom) 어플을 설치해야 합니다.
QR코드를 스캔하여 중 설치 및 사용법을 확인해 보세요.

- 환자들의 선택의 폭을 넓힐 수 있는 **다양한 매체**의 활용(소책자, 영상, 화상면담, 에세이 등)
- 영양, 사회복귀, 부작용, 운동 등 **폭 넓은 주제**의 교육자료 제공

출처: 삼성서울병원 암병원

현 수준

3. 퇴원 안내문 건강관리 사항 및 항암 교육 자료



▲ 본원 암센터의 교육자료

(약 4개의 목차로 10page 정도의 간단하게 정리된 브로슈어 제공)

- **시각화 된 자료가 없어** 고령의 환자, 한글을 모르는 외국인, 노인 등이 접하기 어려운 점이 있음.
- 운동, 경구약 등 다양한 정보 제공 대신 식이, 부작용 교육에 **국한된 정보**

현 수준

3. 퇴원 안내문 건강관리 사항 및 항암 교육 자료

퇴원안내문		
환자번호	환자명 이 ○ ○	성별/생년월일

[퇴원 후 건강관리 및 주의사항]

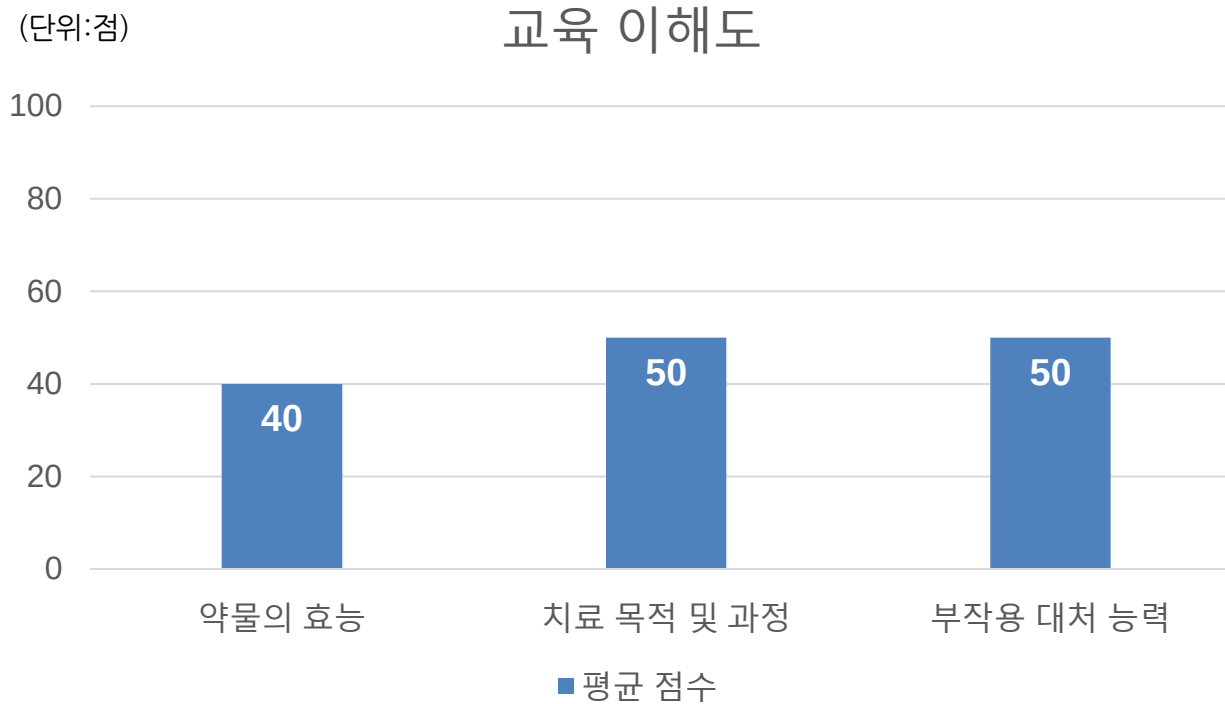
- 오심과 구토는 항암제가 끝난 후에도 일정기간 지속될 수 있습니다. 부드럽고 소화가 잘 되는 음식을 드세요
- 너무 차거나 뜨거운 음식보다는 시원한 음식을 먹는 것이 도움이 됩니다.
- 설사가 있을 경우 카페인, 유제품, 기름진 음식을 피하십시오.
- 설사로 인한 탈수 예방을 위해 수분 섭취를 충분히 하십시오.
- 섬유질이 많은 음식(잡곡밥, 양배추, 껌질째 먹는 과일)을 피하십시오.
- 변비가 생기지 않도록 충분한 수분 섭취(하루 6~10잔)를 합니다.
- 섬유질이 많은 음식(익힌야채, 나물반찬, 견과류)을 먹습니다.
- 힘든 등산이나 다지기 쉬운 운동은 피하십시오.
- 퇴원 후 일상생활 가능합니다.
- 감염예방을 위해 사람이 많은 곳은 피하세요
- 감염자(감기,설사)와의 접촉을 피합니다.
- 외출시, 외출 전후에 감염예방을 위해 항상 손씻기와 마스크 착용을 철저히 합니다.
- 항암치료 후 1~2주일 이내에 구내염이 발생할 수 있으므로 입안을 청결하게 유지하고, 필요에 따라 양치 후 처방된 가글액으로 가글을 합니다.
- 몸을 부딪히거나 머리를 낮추지 않도록 주의합니다.
- 출혈 예방을 위해 부드러운 칫솔, 전기면도기를 사용하시고 외상에 주의하세요.

[퇴원 후 문의를 필요한 사항]

- 오심/구토로 인해 음식을 거의 먹을 수 없는 경우가 지속되거나 증상이 심해지면 가까운 병원 또는 외래진료가 필요합니다.
- 구내염으로 통증이 심하고 음식 섭취가 어려운 경우가 지속되거나 증상이 심해지면 가까운 병원 또는 외래진료가 필요합니다.
- 24시간 이상 설사가 지속되고, 심한 복통이 지속되거나 증상이 심해지면 가까운 병원 또는 외래진료가 필요합니다.
- 변비가 심하여 복통, 배에 가스가 차서 부른 느낌, 메스꺼움이나 구토가 있는 경우(장폐색, 즉, 장운동이 멈추는 것이 의심됨)가 지속되거나 증상이 심해지면 가까운 응급실 또는 외래진료가 필요합니다.
- 상기 증상이 지속되거나 증상이 심해지면 가까운 병원 또는 외래진료가 필요합니다.

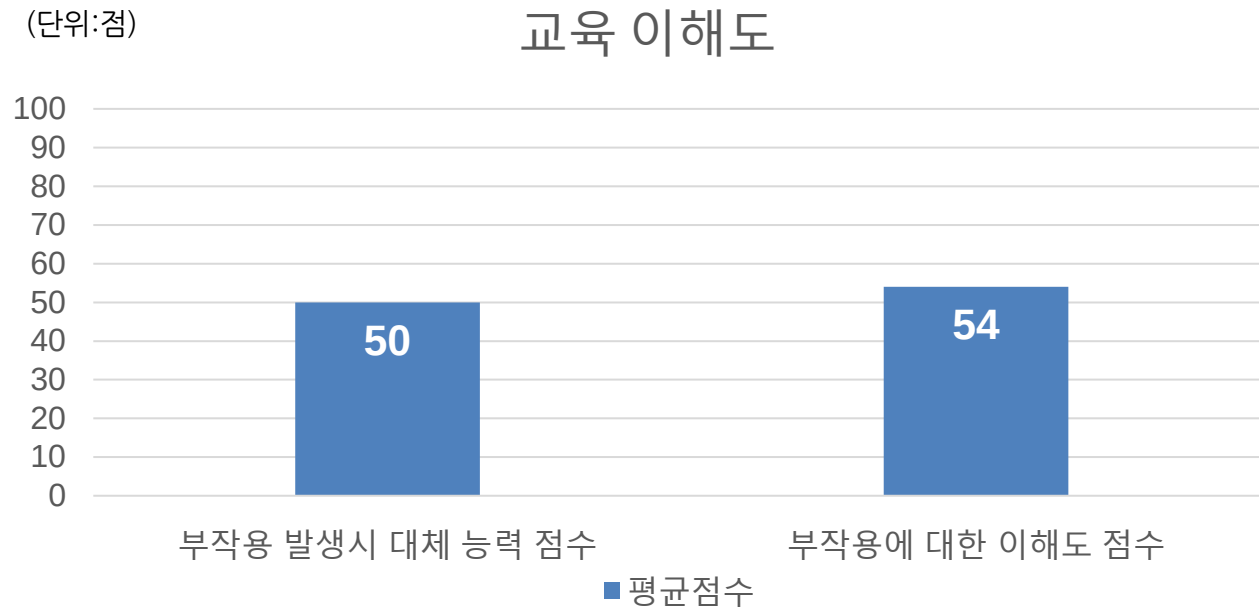
- 자세한 정보 제공에 대한 아쉬움이 있음
- 분실 및 훼손이 쉬움
- 정보의 개정이 어려움

4. 항암치료 대상자들의 교육 이해도



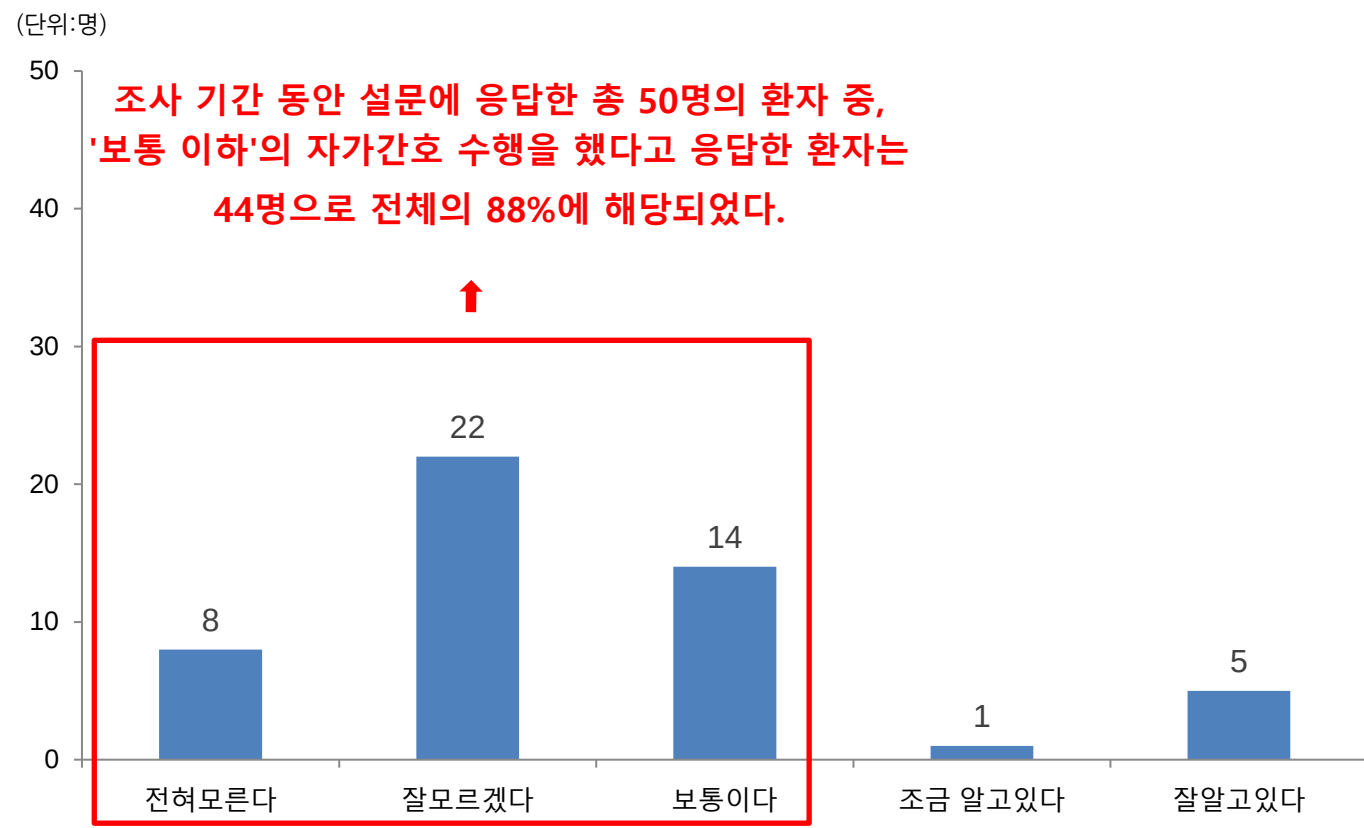
*설문에 응답한 총 50명 환자
<2025. 3. 25 ~ 2025. 4. 7>

4. 항암치료 대상자들의 교육 이해도



*설문에 응답한 총 50명 환자
<2025. 3. 25 ~ 2025. 4. 7>

5. 항암치료 대상자의 자가간호 수행능력



■ 퇴원 후 자가관리 방법에 대한 수행 능력(식이, 운동, 위생, 증상 등)

*설문에 응답한 총 50명 환자
<2025. 3. 25 ~ 2025. 4. 7>

팀 구성

팀장	71병동	박은수
간사	71병동	안지현
팀원	71병동	김도와 박혜림 박진아 권지현 박현지

핵심지표 및 목표

핵심지표

퇴원 후 자가관리 수행도

지표정의

정의 : 항암화학요법 환자가 퇴원 후 자가관리를 수행할 수 있는 정도

분자 : 점수의 총 합

분모 : 설문조사 응답자 수

목표설정

현수준 : 49.2점/100점



목표 : 80점/100점

설정 근거 : 현 수준을 근거로 함.

자료수집

수집방법 : 71병동에 입원, 퇴원하는 항암화학요법 환자의 설문조사

수집기간 : 1차 - 2025 3/24~4/7(N-50)

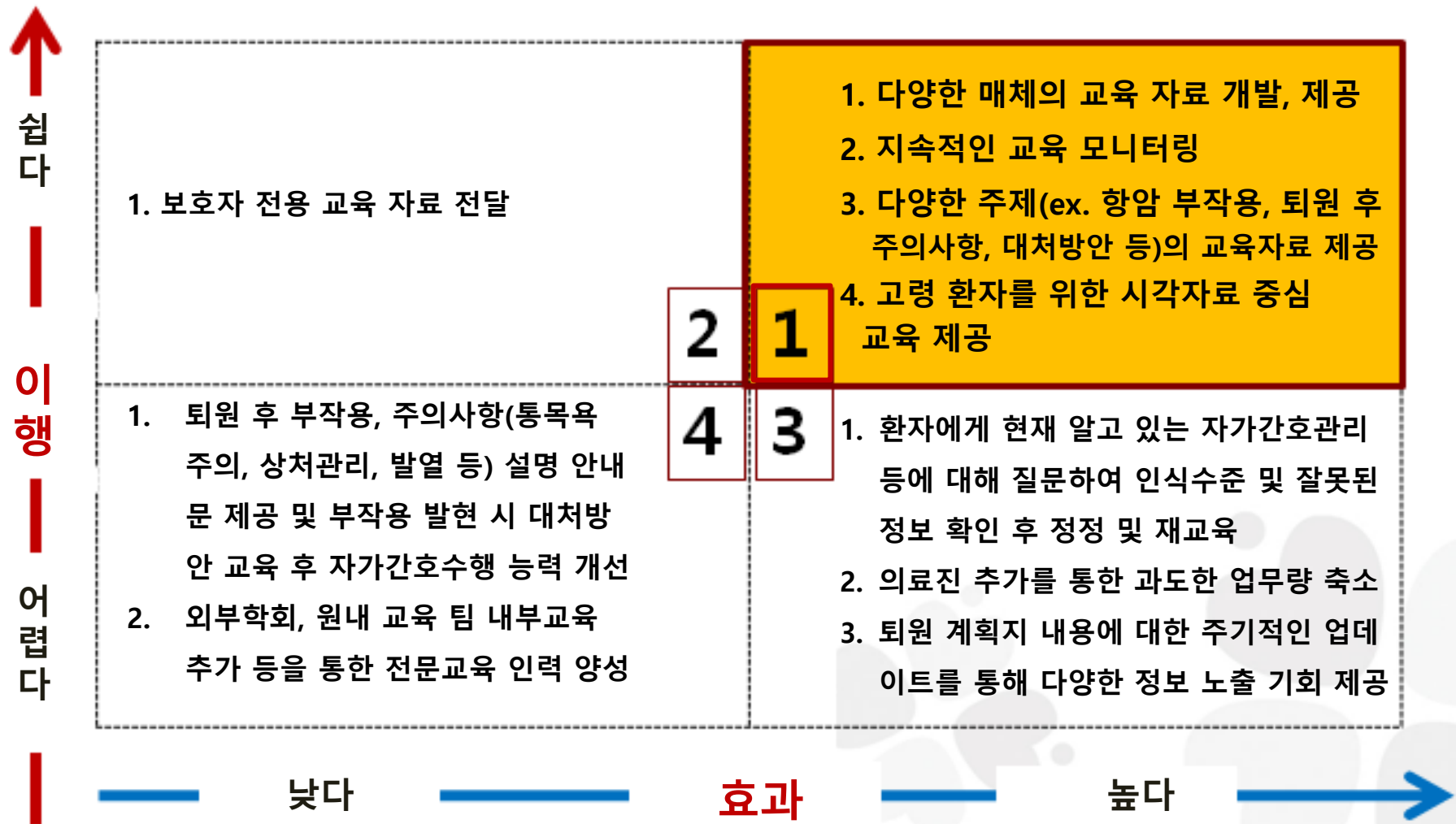
2차 - 2025 9/1~9/30(N-50)

1. 도출된 개선전략 내용

(환경)	(보호자/환자)	(의료진)	(교육)
• 다양한 매체의 교육 자료 개발, 제공 • 지속적인 교육 모니터링	• 퇴원 후 부작용, 주의사항(통목욕 주의, 상처관리, 발열 등) 설명 안내문 제공 및 부작용 발현 시 대처방안 교육 후 자가간호 수행 능력 개선 • 보호자 참고용 교육 자료 전달 • 환자에게 현재 알고 있는 자가 간호 관리 등에 대해 질문하여 인식 수준 및 잘못된 정보 확인 후 정정 및 재교육	• 의료진 추가를 통한 과도한 업무량 축소 • 외부 학회, 원내 교육 팀 내부 교육 추가 등을 통한 전문 교육 인력 양성	• 다양한 주제(ex. 항암 부작용, 퇴원 후 주의사항, 대처방안 등)의 교육자료 제공 • 퇴원 계획지 내용에 대한 주기적인 업데이트를 통해 다양한 정보 노출 기회 제공 • 고령의 환자를 위한 시각자료 중심 교육 제공

개선전략

2. 개선전략 우선순위 선정



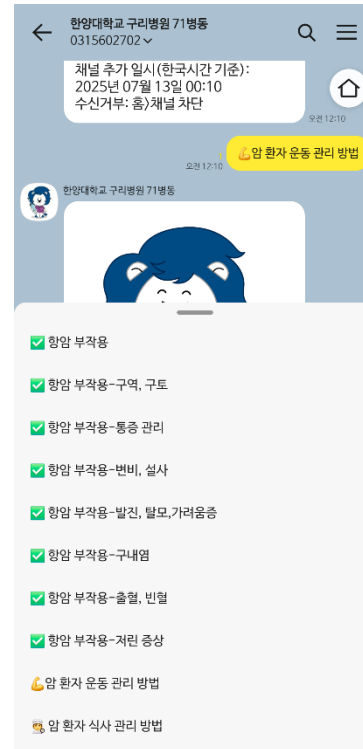
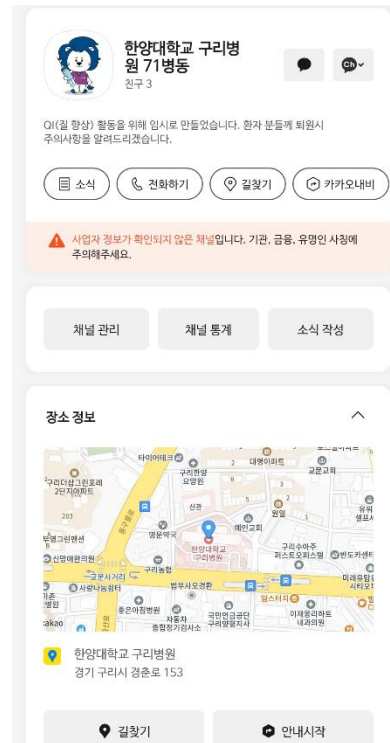
3. 활동계획 수립

핵심문제	개선전략	담당자	기간
병원 밖에서 교육을 이어 갈 수 있는 체계 (전화상담, 방문간호, 앱 등)가 없음	다양한 매체의 교육자료 개발, 제공	팀원 전체	2025 5/1~5/30
퇴원계획지 및 간단한 브 로슈어에 국한된 불충분 한 교육자료	다양한 주제(ex. 항암 부작용, 퇴원 후 주 의사항, 대처방안 등)의 교육자료 제공	팀원 전체	2025 6/1~7/30
고령의 환자들이 많아 교육내용을 집중력 있게 전달하기 어려움	고령의 환자를 위한 시각자료 중심 교육 제공	팀원 전체	2025 6/1~7/30
환자 교육 및 모니터링이 지속적이지 않음	지속적인 교육 모니터링	팀원 전체	2025 8/1~

개선활동 내용

1. 다양한 매체의 교육자료 개발, 제공

카카오톡 채널 개설



언제, 어디서든 부작용, 운동 및 식이 관리법을 빠르게 볼 수 있도록 리스트 설정
이외에도 암환자 관련 자료를 볼 수 있도록 제작하여 공유함

개선헌동 내용

2. 다양한 주제(ex. 항암 부작용, 퇴원 후 주의사항, 대처방안 등)의 교육자료 제공



03. 두통, 설사

항암제의 영향으로 항에서 수분 흡수가 잘 안 되거나 식사활동이 중단될 경우 설사가 발생할 수 있습니다.

- 변비 설사를 대처하는 방법
 - 금식 식사 시에는 장을 쉬게 하면서 실제로 수분과 수분을 보충하기 위하여 보리차와 같은 유동성을 섭취하도록 합니다.
 - 설사가 지속되면, 장이 쉬게 하므로 식사는 소량씩 자주 먹도록 하고, 뜨거운 음식보다는 미지근한 온도의 음식을 먹는 것이 좋습니다.
 - 변비 예방을 위해 물을 많이 마시고, 고섬유질 음식(과일, 채소, 현미밥, 견과류 등)을 섭취하는 것이 도움이 됩니다.
 - 규칙적인 운동은 장의 기능을 향상시켜 변비 증상 완화에 도움이 됩니다.
 - 기스를 차게 하거나 복통을 유발할 수 있는 자극적인 음식은 피하는 것이 좋습니다.
 - 설사가 하루 이상 지속되거나 대변에 혈액이 섞여 있는 경우, 3일 이상 변통 보지 못할 경우 의사와 상담을 통해 치료합니다.



04. 두통, 발열, 가려움증

항암제 투여 후 피부 변화나 발열이 발생하면 상담을 할 수 있습니다. 항암 치료 후 회복할 수 있습니다.

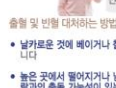
- 피부 자극을 줄이기 위해 순한 비누와 화장품을 사용하고, 면 옷만 착용하는 습관을 들이도록 합니다.
- 강한 햇빛이나 열에 피부부를 직접 노출시키지 않도록 하고, 자외선 차단제나 선글라스, 모자 등을 착용합니다.
- 손발이 붉어지거나 가려움증이 심해지면 물이 닿지 않도록 하며, 알코올 함유 제품은 사용하지 않습니다.
- 발열은 38.5도 이상이면 생리기간 경감기에서 생기는 것은 자연스러운 일입니다. 그러나 서늘하게 미열을 유발하는 것은 도움이 됩니다.
- 가려움증이 있을 때는 오일 시간 도구를 꼭 착용한 후, 크림이나 오일을 발라 진정시키도록 합니다.
- 피부 붉어짐에 통증, 진물이 동반된 경우 의사와 상담을 통해 치료합니다.



05. 구내염

입-항문까지의 위장관의 암적 상피 세포의 손상으로 인한 염증성 반응이 일어날 수 있습니다.

- 구내염 대처하는 방법
 - 가글(생리식염수, 희석액, 베이컨, 다토린)
 - 항암제는 알레르기나 아니라 글수에서 만들어지는 항암제에도 손상시켜 변형 및 출혈 위험이 있을 수 있습니다.



06. 출혈, 변형

출혈 및 변형 대처하는 방법

- 날카로운 것에 베이거나 활과를 입지 않도록 주의해야 합니다.
- 높은 곳에서 떨어지거나 넘어지지 않도록 조심하고, 다른 사람과의 충돌 가능성이 있는 운동(축구, 농구, 탁상, 스키 등)을 하지 않는 것이 좋습니다.
- 혈소판 수치가 낮으면 치실 대신 면이나 구강용 스펀지를 사용하여 양치질을 하십시오.
- 알코올 성분은 구강건조를 일으키므로 알코올을 함유하지 않은 구강항암제를 사용합니다.
- 장상적인 장 기능을 유지하고 과로와 변비를 피해야 합니다.
- 적당한 식사의 운동을 합니다.



07. 말초신경계 증상

말초신경계 증상(손발 저림 등) 대처하는 방법

- 약물치료
- 날카로운 물, 뜨거운 물 사용 시 주의합니다.
- 찬물 접촉 피하기
- 가벼운 스트레칭이나 걷기 운동
- 필요 시 물리치료, 침 치료 등 병행 가능합니다.

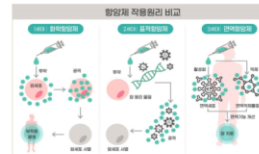


항암제의 정의

항암제의 성장과 증식을 억제하거나 사멸시키는 약물을 사용하여 암을 치료하는 방법

항암제의 종류

세포독성 항암제	항암제의 DNA를 직접적으로 손상시켜 세포 분열을 억제하거나 사멸시키는 약물
표적 항암제	항암제의 특정 표적 분자 (유전자, 단백질 등)에 작용하여 항암제의 성장과 증식에 필요한 신호 전달 경로를 차단하는 약물
면역 항암제	인체의 면역 체계를 활성화시켜 암세포를 공격하도록 유도하는 약물



항암제의 투여경로

- 정맥 주사: 주사 바늘을 정맥에 삽입하여 약물을 투여하는 방법으로 대부분 '항암화학요법'은 정맥 주사 주사 바늘의 큰 정맥에 삽입하거나, '항암화학요법'은 정맥 정맥관을 피부 아래 삽입하여 장기간 사용하는 경우도 있습니다.
- 근육 주사, 피하 주사: 근육이나 피하에 항암제를 투여하는 방법입니다.
- 경구 투여: 알약이나 캡슐 형태의 항암제를 복용하는 방법입니다. 그 외에도 암의 종류에 따라 동맥, 흉막강, 방광, 복부강 및 뇌척수액으로 약물을 투여하는 방법도 사용할 수 있습니다.

항암제 부작용 대처하기



항암제는 암세포뿐만 아니라 정상 세포에도 손상을 입혀 부작용을 일으키게 됩니다. 그러나 부작용을 미리 감지할 수 있습니다. 이러한 부작용이 발생하기 전에 미리 알아두고, 적절하게 대처하면 충분히 조절 가능하기 때문입니다.



이 증상

통증은 암 환자들이 겪는 가장 흔하면서도 고통스러운 증상 중 하나입니다. 암 환자의 대부분이 통증으로 고통을 받고 있습니다.



통증 조절을 위한 비약물 요법
통증을 더욱 효과적으로 조절하기 위해 진통제와 함께 비약물 요법을 활용 할 수 있습니다.

- 마시지, 입밖, 진통: 아픈 부위 주위를 마사지하거나 가볍게 두드려 주는 것입니다.
- 음악이나 텔레비전을 이용한 기분 전환: 통증에만 신경을 집중하지 않도록 좋아하는 음악을 듣거나 텔레비전 프로그램 보는 것입니다.
- 냉찜질이나 온찜질: 아픈 부위에 찬찜질 또는 따뜻한 찜질을 하면 통증이 완화되는 경우가 많습니다.
- 휴식: 움직이면 통증이 더욱 심해지는 경우, 아픈 부위를 고정하거나 휴식을 취해 통증을 줄일 수 있습니다.
- 심호흡과 이완요법: 심호흡과 이완요법은 스트레스로 인한 정신적 긴장과 근육의 긴장을 풀어 통증 완화에 도움이 됩니다.



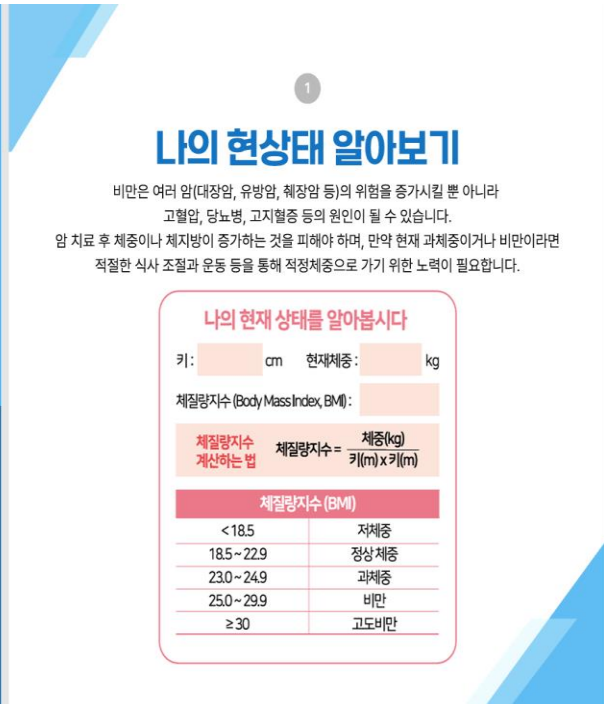
02. 구토

항암제가 위장에 직접 영향을 주거나, 구토를 관장 하는 중추신경계의 특정 부위를 자극하기 때문에 발생 합니다.

- 구역, 구토감을 대처하는 방법
 - 식사는 소량씩 자주 먹도록 하고, 식사 중에는 되도록 물을 마시지 않습니다.
 - 음식을 오랫동안 충분히 씹어서 소화 잘 되도록 합니다.
 - 자극적인 냄새(고기, 향수 등)의 음식은 가능한 피하도록 합니다.
 - 심호흡을 하거나 알코올을 많이 마시고 있으면 도움이 됩니다.
 - 통풍이나, 손이나 발가락을 따뜻하게 하고 손을 따뜻하게 합니다.
 - 입을 자주 헹가서 상쾌한 상태를 유지하도록 합니다.
 - 항암제 투여 1-2시간 전에는 식사를 하지 않고, 식사 후 2시간 동안은 눕지 않는 것이 좋습니다.
 - 신지르지 않게 움직임을 천천히 하고, 구토를 할 때에는 기도 막 하지 않게 몸을 굽히도록 합니다.

항암의 정의, 종류, 투여경로 설명과 퇴원 후 발생할 수 있는 다양한 항암제 부작용 대처 방법에 대한 팜플렛 제작

3. 고령의 환자를 위한 시각자료 중심 교육 제공



건강한 식생활 관리 방법에 대한 교육자료를 만들어 퇴원 시 제공

개선활동 내용

3. 고령의 환자를 위한 시각자료 중심 교육 제공



- 스트레칭 및 간단한 동작을
포스터로 제작하여 퇴원 시 공유
- **QR 코드**를 이용하여 영상으로
볼 수 있도록 다양한 시각자료
교육 제공

3. 고령의 환자를 위한 시각자료 중심 교육 제공



병실마다 포스터 비치
하여 운동 격려

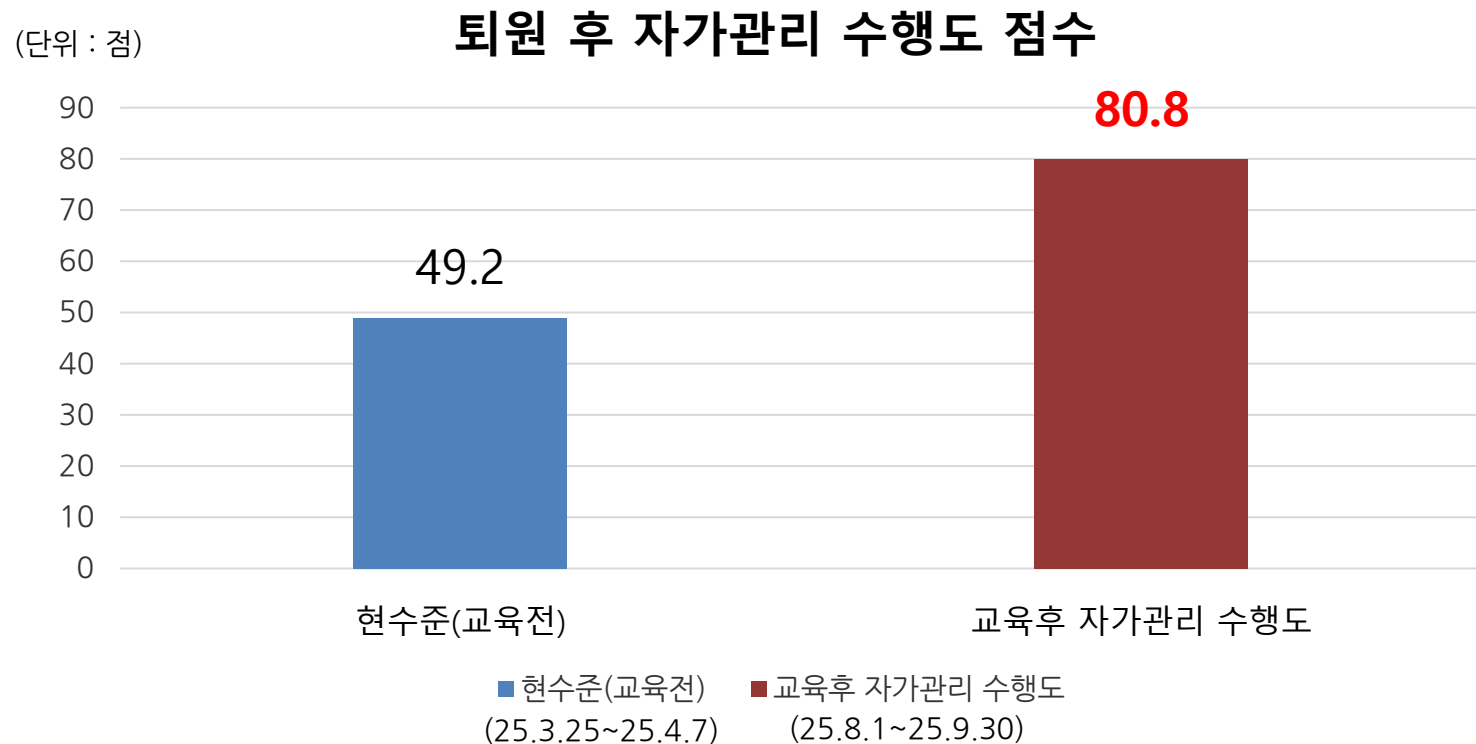
3. 고령의 환자를 위한 시각자료 중심 교육 제공



제작한 **팜플렛 및 교육자료 제공**하여 퇴원 전 교육

개선활동 결과

1. 핵심지표 결과 평가



목표설정

현수준 : 49.2점/100점



목표 : 80점/100점

설정 근거 : 현 수준을 근거로 함.

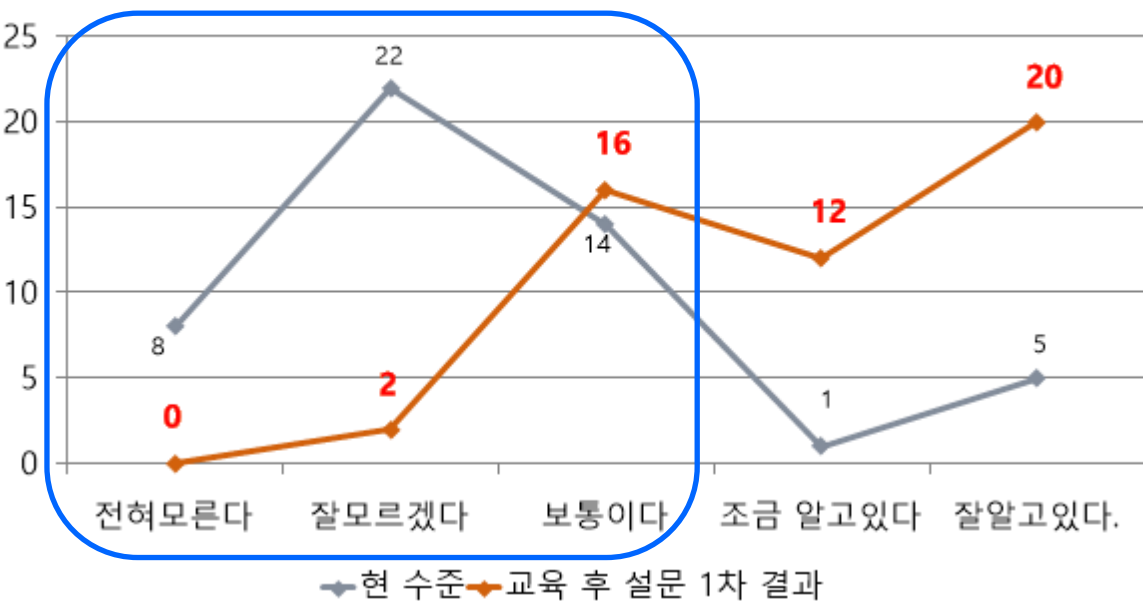


P단계의 목표 수준 달성

개선활동 결과

1. 핵심지표 결과 평가

퇴원 후 자가관리 방법에 대한 수행 능력(식이, 운동, 위생, 증상 등)



조사 기간 동안 설문에 응답한 총 50명의 환자 중, '보통 이하'의 자가간호 수행을 했다고 응답한 환자는 **44명으로 전체의 88%**
 ↓
18명으로 전체의 36%로 감소

*설문에 응답한 총 50명 환자
 <2025. 3. 25 ~ 2025. 9.30>

퇴원 후 자가관리 수행도 **평균 점수가 49.2점에서 80.8점으로** 향상되어 목표를 달성하였다.

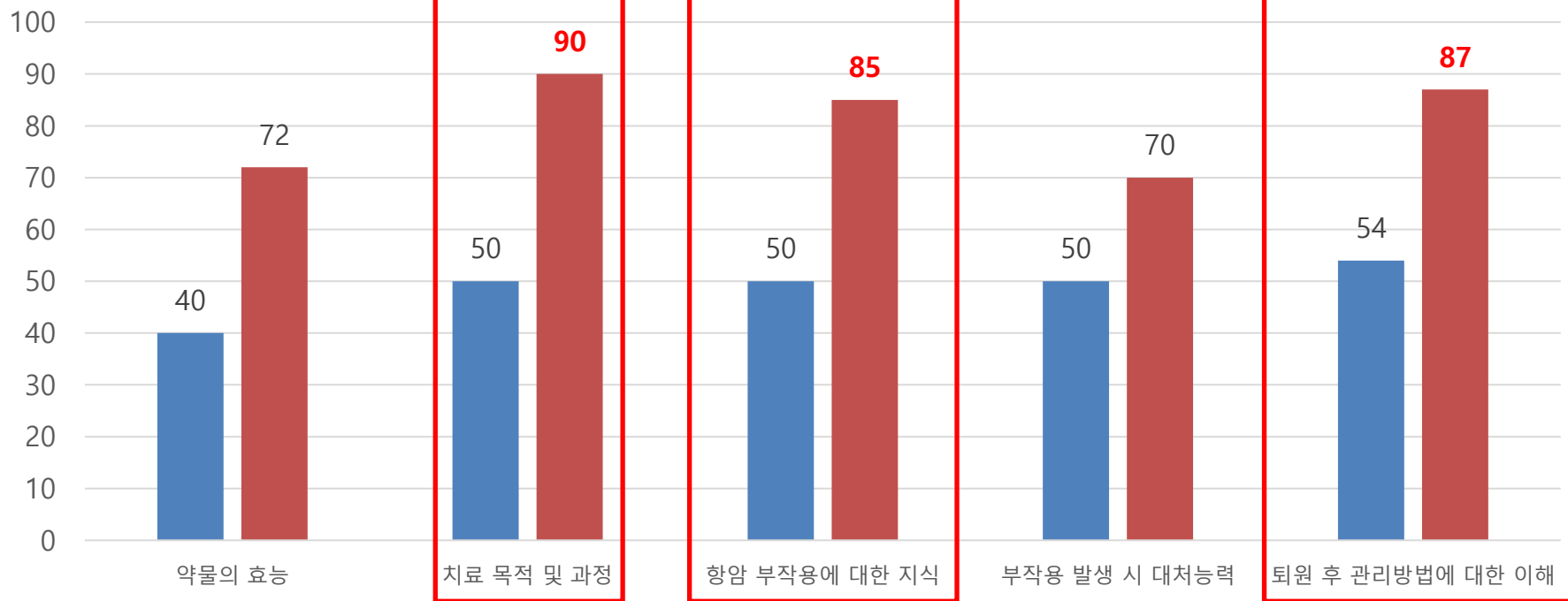
개선활동 결과

1. 핵심지표 결과 평가

▶ 문항별 세부 분석

항암화학요법 대상자들의 교육 이해도

(단위 : 점)



■ 현수준(교육전 설문) (25.3.25~25.4.7)

■ 교육 후 수행도 결과 (25.8.1~25.9.30)

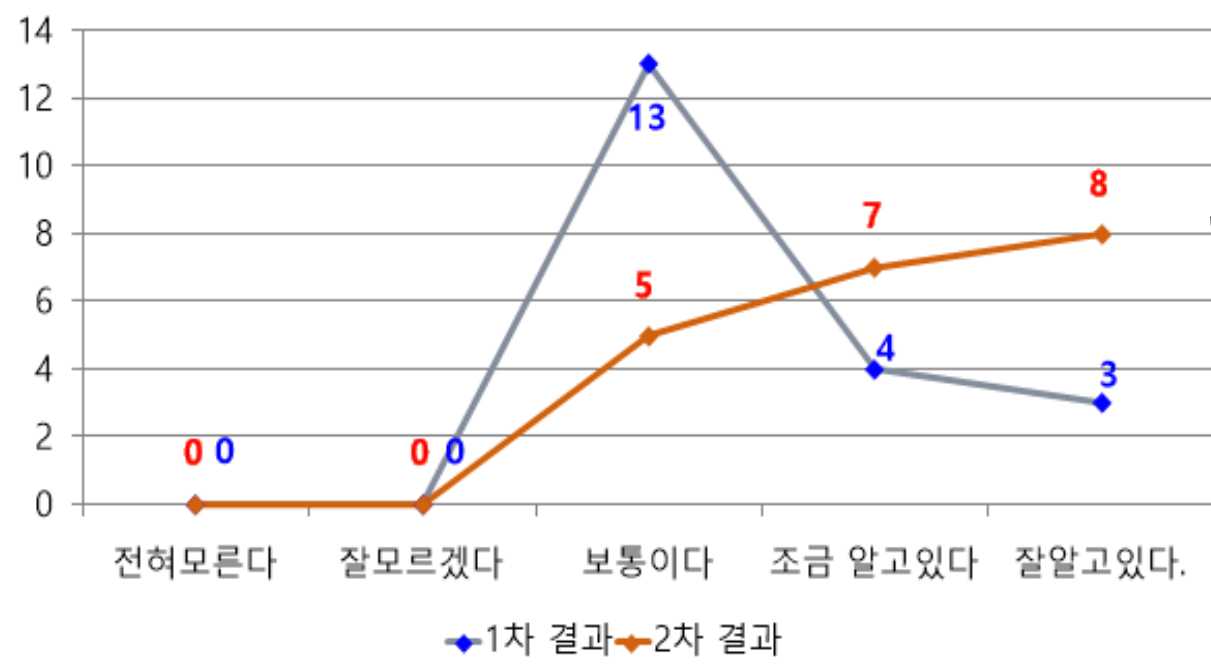
*설문에 응답한 총 50명 환자

개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과평가

가. 고령환자(66세 이상)의 자가관리 수행 능력 변화

퇴원 후 자가관리 방법에 대한 수행 능력(식이, 운동, 위생, 증상 등)



조사 기간 동안 설문에 응답한
66세 이상의 20명의 환자 중,
'보통 이하'의 자가간호 수행을
했다고 응답한 환자는
13명, 전체의 65%

↓
5명, 전체의 25%로 감소

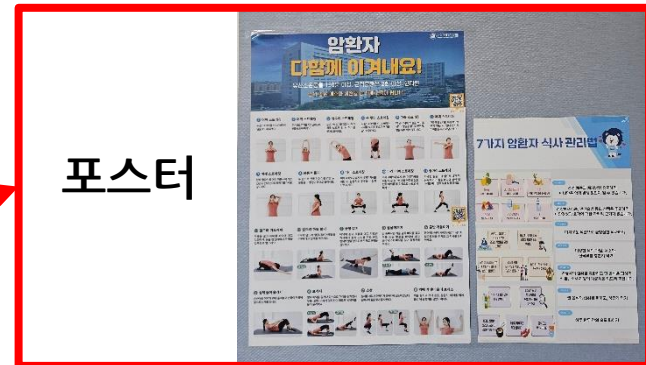
*설문에 응답한 66세 이상 환자 20명
<2025. 3. 25 ~ 2025. 9.30>

개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과평가

나. 교육 매체 종류 변화

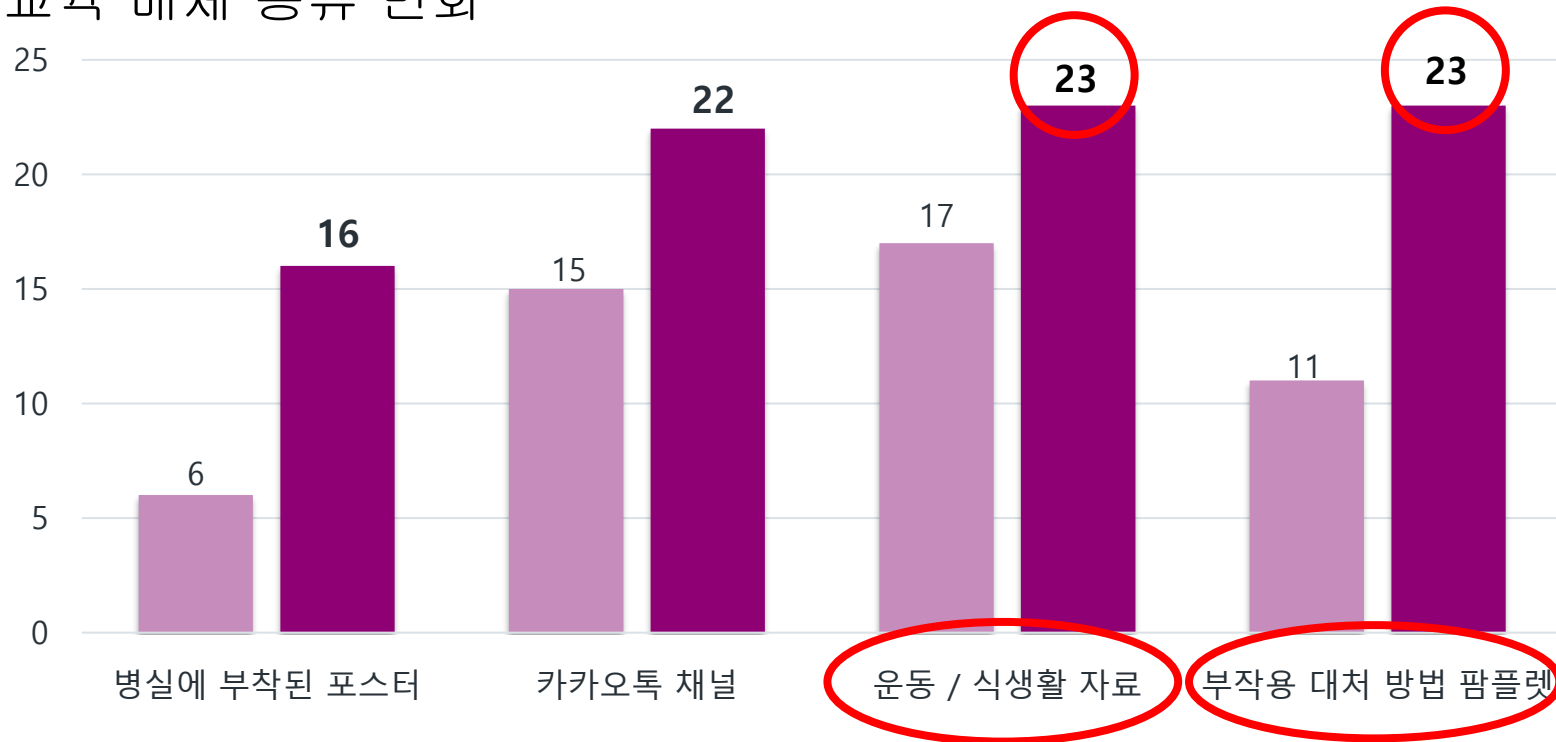
종이 매체에서 카카오톡 채널, 팸플렛, 포스터로
교육 매체가 **다양해졌다.**



종이자료
(예. 퇴원 후 건강계획지,
암센터 교육자료)

2. 핵심지표 외 효과평가

나. 교육 매체 종류 변화



■ 처음 조사시 매체 선호도 2025. 3. 25~2025. 4. 7 ■ 교육 후 매체 선호도 2025. 8. 1~2025. 9. 30

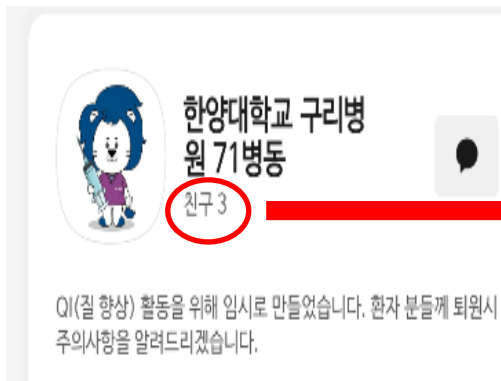
*설문에 응답한 총 50명 환자(중복 선택)

개선활동 결과

2. 핵심지표 외 효과평가

다. 카카오톡 채널 친구 수(접속자 수) 변화 추이

2025.07.31 기준 : 친구 수 3명



2025.10.20 기준 : 친구 수 55명



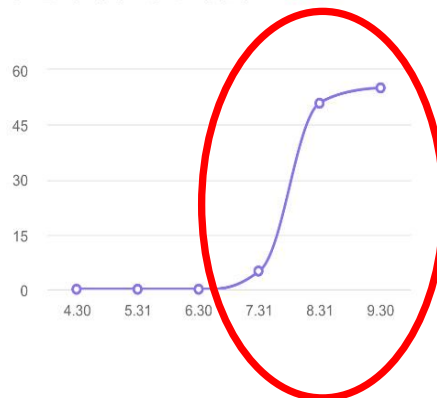
주간

월간

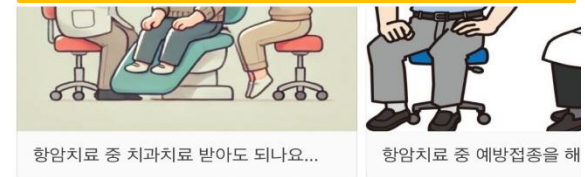
< 2025년 9월 >

내 채널의 이번달 친구수는 55명입니다.

지난달에 비해 4명 증가했어요. 7.8% ▲



<카카오톡 채널 활동본 : 실시간 Q&A>



좋아요 1 · 댓글 10 · 공유 1

2025.08.28. 오후 7:27

항암중입니다.
항암치료후 퇴원후 종아리 발목등에톡톡 불거지며 발지라고
가려울때 동네병원에서 예전에 처방받은 스테로이드 시원
속껍이 있습니다. 발라도 되는지요.감사합니다.

2025.08.28. 오후 9:02

근치적이 아닌 항암치료 환자의 짧은3박5일의 동남아 같은
곳 해외여행은 가능한지요?
감사합니다.

한양대학교 구리병원 71병동

2025.08.29. 오후 8:33

스테로이드성 겔같은 경우는 피부가 얇아지거나 혈관이 약
해질 수 있어 사용하게 될 경우 주치의와 상의 후 사용하시길
바랍니다.

한양대학교 구리병원 71병동

2025.08.30. 오후 3:45

여행같은 경우는 가능하지만 항암을 하면 면역력이 저하되
어 해외 음식이나 사람 많은 곳을 조심하시길 바랍니다

개선활동 평가

궁극적으로 얻게 된 것??

항암치료 환자의 퇴원 후 자가관리 수행능력 향상

• 운동, 식생활, 항암치료 부작용 관리 팸플릿

- 1) 한 눈에 정리된 자료를 통해 퇴원 시
참고 자료로 활용되어 환자의 이해도가 높아졌다.
- 2) 고령 및 SNS를 사용하지 않는 환자들에게도
쉽고 편리한 정보 접근이 가능해졌다.

• 카카오톡 채널

환경과 시간에 제약을 받지 않는 정보로 접근이
용이해졌으며 다양한 주제 제공 및 질의 응답을
통해 환자의 궁금증을 실시간으로 해소할 수 있다.

• 포스터

병동 곳곳에 자료를 배치하여 환자들의 접근성이
용이하였으며, 운동 영상 및 식이 참고 자료를
실시간으로 활용하여 무료한 병실 생활에 활력을
더해주는 효과를 가져올 수 있었다.



확대 및 유지관리 방안

01

다른 부서와 협업을 통한 적극적·지속적인 항암교육 강화

처음 항암을 시작하는 환자에게는 치료 이해를 돕기 위해 “다학제/암센터/외래”에서 미리 교육 제공 핵심지표 문항별 세부분석 중 “약물의 효능”에 대한 이해도 점수가 낮아 치료중인 환자에게는 재교육 필요성을 확인한 후 필요 시 추가 교육 실시

02

카카오톡 채널 담당 관리자 선정

다양한 정보 및 질문에 대한
답변의 주기적인 업데이트를
위해 병동 내 담당 관리자를 선정



항암치료 환자의 퇴원 후
자가관리 수행능력 향상



03

암환자들을 위한 운동 프로그램 운영

자원봉사자를 선정하여 주 1회
신청자를 대상으로 스트레칭
및 운동 교육을 제공

04

부서원들의 적극적 참여

부서원들에게 지속적이고 통일화된
교육을 제공하여 역할임무에 대한
적극적인 참여와 관심을 유도

요약결과보고서

주제명	항암치료 대상자의 치료 및 퇴원 후 자가 관리 교육 활동
팀원	김도와, 박은수, 안지현, 박혜림, 박진아, 권지현, 박현지
활동의 필요성	여러 차례 항암치료를 시행한 다수 환자들이 비슷한 질문이 반복되고 있고, 체계적이고 통일화된 정보 제공의 부족과 상담 시간 제약으로 환자 지식 습득이 어려우며, 특히, 고령 및 처음 항암치료 환자의 자가 관리 능력이 부족해 부담이 증가하고 있다.
문제 분석 (현 수준)	글로 적힌 암 센터 책자나 서면으로 된 항암동의서를 보며 시각화된 자료가 부족하여 고령 환자의 정보 접근이 어려우며, 퇴원 시 퇴원간호계획지로 제한된 내용의 정보 제공으로 인해 자가간호 수행 능력이 부족한 환자가 증가하고 있다.
핵심지표 및 목표	핵심지표는 “항암화학요법 환자들의 퇴원 후 자가관리 수행도”로 설정했다. 목표는 자가관리 수행도가 현 수준(교육 전) 49.2점에서 교육 후 설문조사 시 80점으로 향상하는 것이다. (0/100점)
개선활동	다양한 매체(포스터, 팸플렛)와 주제(항암 부작용, 퇴원 후 주의사항 등)의 교육자료를 제공하고 병실 곳곳에 배치하며 반복적인 교육과 퇴원 시 참고할 수 있는 자료는 제공되어 SNS가 힘든 환자들에게도 접근하기 쉽게 교육자료를 개발했다. 또한, 환경에 제약을 받지 않고 실시간으로 질의응답이 가능해지는 카카오톡 채널을 개설하여 퇴원 후에도 궁금증을 해소할 수 있게 되었다.
개선활동의 효과	퇴원 후 항암화학요법 치료중인 환자들의 자가관리 수행도가 49.2점에서 80.8점으로 상승했다. 교육매체는 퇴원간호계획지 또는 암 센터 교육자료와 같은 종이류 매체 1가지에서 팸플렛, 포스터, 카카오톡 채널 3가지 매체로 늘었으며 카카오톡 채널 친구수가 3명에서 55명으로 증가했다.
결론 및 향후 관리방안	여러 매체를 활용한 자료와 폭넓은 주제로 시간, 공간, 나이의 제약없이 환자의 교육 이해도와 정보 접근성을 높이고, 병동 내 자료 배치와 운동 영상 제공을 통해 병실 생활에 활력을 제공했다. 향후, 다른 부서(암 센터, 외래, 다학제 등)와 협업을 통해 적극적이고 지속적인 항암치료 교육을 확대하고, 카카오톡 채널 관리자 선정을 통해 주기적으로 정보 업데이트로 환자들의 궁금증에 대한 빠른 피드백이 이뤄질 수 있도록 한다. 또한, 자원봉사자를 선정하여 암환자 운동 프로그램을 운영하며 부서원들에게 지속적이고 통일된 교육을 통해 각자의 역할과 임무에 대한 참여를 유도한다.